

Bulimia Nerviosa

TCC — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

La Bulimia Nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de atracones seguidos de conductas compensatorias (purga, ayuno, ejercicio excesivo) y una evaluación de la autoestima excesivamente influenciada por el peso y la forma corporal. La TCC-E (Fairburn) es el tratamiento psicológico de primera línea con evidencia de alta calidad.

TÉCNICAS E INTERVENCIONES TCC — PASO A PASO

1	Psicoeducación y formulación personalizada Presentar el modelo cognitivo de la BN (Fairburn): el círculo central dieta → atracón → purga mantenido por la sobrevaluación del peso/forma. Construir formulación conjunta con el paciente.
2	Regularización de la ingesta Establecer comidas y snacks por día en horarios regulares. Este es el componente más potente. No restringir tipos de alimento. El objetivo es interrumpir el ciclo restricción-atracón.
3	Automonitoreo alimentario Registro de: hora, alimento ingerido, contexto (lugar, acompañante), pensamientos y emociones. No para 'controlar' la alimentación sino para identificar disparadores cognitivos y emocionales del ciclo.
4	Identificación de disparadores del atracón Analizar registros para identificar patrones: ¿hay situaciones emocionales, interpersonales o cognitivas que preceden al atracón? Trabajar cada disparador específicamente.
5	Trabajo con imagen corporal Identificar conductas de verificación (pesarse múltiples veces, mirarse, compararse) y de evitación. Exposición a espejo con descripción neutral. Reestructuración de pensamientos sobre el cuerpo.
6	Reestructuración de creencias sobre peso/forma Ampliar la autoestima más allá del peso. Explorar áreas de valor: relaciones, logros, capacidades. Trabajo con el perfeccionismo y la autoexigencia subyacente.
7	Prevención de recaídas Identificar situaciones de alto riesgo. Plan de manejo de lapsos (un episodio) vs. recaída (retorno al patrón). Normalizar dificultades sin catastrofizar.

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	Evaluar siempre comorbilidades (depresión, TLP, trauma). En casos con inestabilidad emocional marcada, considerar DBT. Coordinación con nutricionista y médico.

Bulimia Nerviosa

TCC — Ficha clínica

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adolescentes	Edad de mayor prevalencia. Involucrar a la familia sin hacer del peso el foco de atención familiar. Evaluar contexto: presión social, redes, deportes de alto rendimiento.
Adolescentes tardíos/universitarios	Contexto de autonomía e independencia. El modelo breve de autoayuda guiada (Fairburn) puede ser un primer paso. Acceso limitado a recursos — considerar formato digital.

Clave clínica: La regularización de la ingesta interrumpe el ciclo restricción-atracón y es el cambio conductual más importante. Debe establecerse antes de cualquier trabajo cognitivo.